

Eskalacja *behawioralna*

To, co kiedyś wystarczało, dziś nie wystarcza. Co kiedyś szokowało, teraz jest nudne. Eskalacja w PPU ma 4 znane formy — i nie u każdego występuje.

CZAS: 25 min Psychoedukacja + autorefleksja

ŹRÓDŁO: Wood (2013); Park i wsp. (2016); Brand i wsp. (2019)

JAK UŻYWAĆ

Karta opisuje **cztery formy eskalacji** behawioralnej w PPU: 1) *ilościowa* — więcej czasu, częściej, 2) *treściowa* — bardziej intensywne, ekstremalne lub nietypowe materiały, 3) *kontekstowa* — używanie w nowych okolicznościach (praca, ryzyko, publicznie), 4) *kompulsywna* — utrata kontroli nad decyzją. Karta pomaga rozpoznać, **która forma występuje u Ciebie** i co z niej wynika dla terapii. *Uwaga:* nie wszyscy z PPU eskalują — u części używanie pozostaje stabilne przez lata.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Eskalacja behawioralna w PPU była opisywana od lat 80. (Carnes), ale długo bez solidnej empirii. Współczesne badania potwierdzają częściowo: Wood (2013) i Park i wsp. (2016) w retrospektywnych badaniach pacjentów klinicznych pokazują, że **40-60% osób z CSBD** opisuje doświadczenie eskalacji *treściowej* (potrzeba „mocniejszych” materiałów) i **50-70%** — eskalacji *ilościowej*. Mechanizm: regulacja receptorów dopaminowych „w dół” (Volkow 2009) — mózg potrzebuje silniejszej stymulacji dla tego samego efektu. *Ale:* zjawisko nie dotyczy wszystkich (Prause & Pfaus 2015 znaleźli badania, gdzie eskalacja nie zachodzi). Świadomość tego pomaga rozpoznać, w której grupie się jesteś.

01 📋 Cztery formy eskalacji

1 · ESKALACJA ILOŚCIOWA

więcej, częściej, dłużej

Czas korzystania rośnie (z 30 min/tydz. → 2 h/dzień). Częstotliwość rośnie. Sesje wydłużają się. *Najczęstsza i najwcześniejsza forma.*

Sygnał: nie pamiętam, kiedy ostatnio nie używałem tygodniami.

2 · ESKALACJA TREŚCIOWA

mocniejsze, ekstremalniejsze

Treści „łagodne” przestają działać. Szukam coraz bardziej ekstremalnych, niekiedy sprzecznych z własną orientacją czy wartościami (chambering, etyczne dylematy).

Sygnał: moje treści dziś by mnie szokowały rok temu.

3 · ESKALACJA KONTEKSTOWA

w coraz bardziej ryzykownych miejscach

W pracy, w toalecie, w aucie, podczas innych zajęć. Ryzyko nakrycia rośnie, ale przyciąga zamiast odstraszać („jeszcze większy haj”).

Sygnał: używałbym/-abym wcześniej w sytuacjach, których kiedyś bym uniknął/-ęła.

4 · ESKALACJA KOMPULSYWNA

utrata decyzji

Nawet gdy nie chcę, robię. Czuję, że „to się dzieje samo”, a moja świadoma decyzja przestaje mieć znaczenie. *Najbardziej kliniczna forma* — kryterium CSBD.

Sygnał: próby ograniczenia kończą się porażką wbrew mojej intencji.

02 🕒 Co napędza eskalację — trzy mechanizmy

TOLERANCJA

Mózg „przyzwyczaja się” do dawnego poziomu stymulacji. Receptory dopaminowe D2 obniżają wrażliwość. Ten sam materiał daje mniej.

NOWOŚĆ COOLIDGE'A

„Efekt Coolidge'a” w neurobiologii: nowy bodziec daje większy skok dopaminy niż znany. Mózg szuka nowości — coraz dalszej.

ALGORYTMY PLATFORM

Strony pornograficzne mają algorytmy rekomendacji uczone na maksymalizację czasu — celowo proponują coraz bardziej intensywne treści.

03 Twoja eskalacja — autorefleksja

ILOŚCIOWA

— ile czasu / razy tydzień rok temu vs dziś

TREŚCIOWA

— jakie treści rok temu vs dziś

KONTEKSTOWA

— gdzie rok temu vs dziś

KOMPULSYWNA

— ile razy próbowałem/-am ograniczyć bez powodzenia

04 Co eskalacja mi mówi — wnioski

KTÓRA FORMA U MNIE NAJSILNIEJSZA

— 1, 2, 3 czy 4

CO TO MI MÓWI O ETAPIE ZAAWANSOWANIA

— łagodny / umiarkowany / kliniczny

Co działa przeciwko eskalacji:

- 1) Świadomość mechanizmu — nie walczę z „nudą mózgu”, tylko ją rozpoznaję jako sygnał
- 2) Okresy abstynencji — pozwalają receptorom „zresetować” wrażliwość (3+ miesiące)
- 3) Kontrola algorytmu — używanie z trybu prywatnego, czyszczenie historii, blokery „related videos”
- 4) Naturalne bodźce — partnerka/-rz, ćwiczenia, twórczość, jedzenie — buduj alternatywne źródła dopaminy

Klucz: Park i wsp. (2016) i Wood (2013) podkreślają, że **eskalacja jest predyktywna dla cierpienia klinicznego** — pacjenci z aktywną eskalacją (zwłaszcza treściową lub kompulsywną) mają 3× wyższe ryzyko spełnienia kryteriów CSBD niż osoby ze stabilnym wzorcem używania. Z drugiej strony: **eskalacja nie jest nieunikniona**. Część osób utrzymuje umiarkowane, stabilne używanie latami bez progresji. Co odróżnia te grupy? Najsilniej: *cechy osobowości* (impulsywność, poszukiwanie nowości), *współwystępujące zaburzenia*, *kontekst społeczny*. Praktyczna konsekwencja: rozpoznanie eskalacji u siebie to *sygnał* do działania, nie samoocena.